

项目编号	TJ202513666034
------	----------------

武汉华夏理工学院

结 项 报 告

健康视角下农村公共服务设施规划问题的研究——以罗田县胜利镇为例

推 荐 学 院 土木建筑工程学院

项 目 名 称 健康视角下农村公共服务设施规划问题的研究——以罗田县胜利镇为例

项 目 类 型 ☒创新训练项目 ☐创业训练项目 ☐创业实践项目

项目负责人 李慧琳

指 导 教 师 杨喧

填 写 日 期 2026.5

目 录

摘要.....	1
第一章 绪论.....	2
1.1 研究背景.....	2
1.2 研究目的与意义.....	2
1.3 国内外研究综述.....	3
1.4 研究内容、方法与技术路线.....	3
第二章 相关概念与理论基础.....	4
2.1 核心概念界定.....	4
2.2 相关理论基础.....	4
第三章 罗田县胜利镇公共服务设施现状调查.....	5
3.1 研究区域概况.....	5
3.2 教育设施现状.....	6
3.3 医疗设施现状.....	8
3.4 养老服务设施现状.....	10
3.5 文体与健身设施现状.....	11
3.6 基础设施现状.....	12
第四章 健康视角下公共服务设施问题分析.....	14
4.1 公共服务设施可达性分析.....	14
4.2 设施供给与老龄化需求的错位.....	14
4.3 设施服务质量与管护困境.....	15
第五章 规划优化建议.....	17
5.1 构建“健康乡村”公共服务设施评价体系.....	17
5.2 优化公共服务设施空间布局.....	17
5.3 提升设施适老化水平.....	17
5.4 完善设施管护长效机制.....	17
第六章 结论与展望.....	18
6.1 主要结论.....	18
6.2 研究创新与不足.....	18
6.3 未来展望.....	18
参考文献.....	19

摘要

建设健康乡村是实施乡村振兴战略的重要内容，也是健康中国建设在农村地区的具体实践。当前，我国农村地区公共服务设施在空间布局、服务质量、适老化水平等方面仍存在明显短板，难以满足农村居民日益增长的健康生活需求。本研究以湖北省罗田县胜利镇为典型案例，综合运用田野调查、问卷调查、半结构化访谈、GIS 空间分析和层次分析法（AHP）等方法，系统调查了该镇教育、医疗、养老、文体及基础设施等公共服务设施的现状，深入分析了其存在的主要问题及其成因。

研究发现，胜利镇公共服务设施面临三大核心困境：一是指标体系缺失，缺乏科学、系统的评价标准来指导设施的规划与优化；二是设施供给与老龄化需求存在明显错位，适老化水平普遍偏低；三是管护机制不完善，运营效率低下，“重建设、轻管理”现象突出。针对上述问题，本研究构建了适用于湖北省农村的“健康乡村”公共服务设施评价体系，提出了教育医疗设施优化布局方案及适老化改造策略，并从评价体系构建、空间布局优化、适老化提升和管护机制完善四个方面提出了系统的规划建议。研究成果可为罗田县及其他相似乡镇的公共服务设施规划提供科学参考。

关键词：健康乡村；公共服务设施；适老化；GIS 分析；层次分析法；罗田县胜利镇

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 健康中国战略与健康乡村建设的时代要求

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。2016 年《“健康中国 2030”规划纲要》的发布，标志着健康中国建设上升为国家战略。2024 年，国家卫生健康委等部门联合印发《关于推进健康乡村建设的指导意见》，明确提出到 2035 年“建成健康乡村”的目标，要求将健康理念融入乡村公共政策制定实施的全过程。这一政策导向为农村公共服务设施规划提供了新的理论视角和实践方向。

1.1.2 农村公共服务设施规划的迫切需求

长期以来，受城乡二元结构的影响，我国农村地区公共服务设施建设存在历史欠账多、发展不平衡、服务质量参差不齐等问题。在教育领域，农村学校普遍面临生源流失、师资短缺、教学设施陈旧等困境；在医疗领域，村卫生室设备简陋、药品短缺、人才匮乏问题突出；在养老领域，农村老龄化进程加速，而养老服务设施却几乎空白。因此，开展健康视角下农村公共服务设施规划问题的研究，具有重要的理论价值和现实意义。

1.1.3 罗田县胜利镇研究的典型意义

罗田县位于湖北省东北部、大别山南麓，属于典型的山区农业县。胜利镇作为罗田县下辖的一个中心镇，其公共服务设施建设状况反映了当前我国中部地区农村公共服务设施发展的普遍特征：有一定基础但短板突出，面临教育、医疗、养老等多重供给压力，特别是人口老龄化背景下适老化改造需求迫切。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本研究以罗田县胜利镇为研究对象，从健康乡村视角出发，系统调查农村公共服务设施建设现状，深入分析存在的问题及成因，构建适用于湖北省农村的公共服务设施评价体系，提出规划优化策略，为农村公共服务设施的规划建设提供科学依据。

1.2.2 理论意义

一是丰富健康乡村理论内涵，将健康乡村理念从医疗卫生领域拓展至教育、养老、文体等公共服务设施领域；二是创新研究方法，融合 GIS 空间分析、层次分析法和社会调查等多种技术方法；三是完善评价体系，构建适用于农村地区的公共服务设施评价指标体系。

1.2.3 实践意义

为胜利镇公共服务设施的优化布局和适老化改造提供直接指导；为罗田县及其他相似乡镇的公共服务设施规划提供参考范本；为湖北省推进健康乡村建设和乡村振兴战略实施提供科学支撑。

1.3 国内外研究综述

1.3.1 公共服务设施可达性研究

吴建军等（2008）运用 GIS 技术评估了农村医疗设施的空间分布特征，研究表明农村地区医疗设施分布存在相当程度的空间不均衡性。^[1]杨俊等（2024）对黔西市公共服务设施空间布局进行了研究，分析了医疗保健、科教文化等设施的空间分布特征。^[2]刘小英等（2024）采用潜能模型和网络分析法，从设施可达性和覆盖率两个方面对乡村公共服务设施适老化布局进行了评估。^[3]在江汉平原农村基本公共服务均等化研究方面，已有学者以仙桃市为研究区域进行了系统分析。

1.3.2 农村公共服务设施规划研究

在规划理念层面，“柔性生活圈”概念的提出为农村公共服务设施配置提供了新思路（蔡云楠等，2025）。^[4]相关研究认为，乡村公共服务设施的配置应从乡村居民的实际需求出发，结合居民群体特征、使用需求和时空行为特征，实现服务质量的最优化。在布局优化层面，杨慧（2023）强调应实现从“人找服务”到“服务找人”的转变。在适老化层面，已有研究关注到农村老龄化率快速增长与老年宜居环境建设整体落后的矛盾。^{[5][6]}

1.3.3 健康乡村建设研究

《关于推进健康乡村建设的指导意见》（2024）从提升乡村医疗服务水平、提升乡村公共卫生服务能力、改善乡村健康环境、普及健康生活方式、完善乡村健康保障机制等方面明确了重点任务。在评价体系方面，已有学者借鉴 PSPL 调研法和健康乡村评价指标体系，对乡村公共空间与健康营建的关系进行了研究。^[7]

1.3.4 研究述评

现有研究仍存在以下不足：一是健康乡村视角下对公共服务设施的系统性研究较少，多聚焦于医疗设施单方面；二是评价指标体系研究相对滞后；三是适老化研究尚处于起步阶段。本研究拟从健康乡村视角出发，以教育、医疗、养老三大核心公共服务设施为研究对象，探索系统性的规划优化方案。

1.4 研究内容、方法与技术路线

1.4.1 研究内容

（1）文献研究与理论构建；（2）现状调查与数据采集；（3）问题诊断与定量分析；（4）规划建议与对策研究。

1.4.2 研究方法

文献研究法、田野调查法、问卷调查法（回收有效问卷 210 份）、半结构化访谈法、GIS 空间分析法、层次分析法（AHP）。

1.4.3 技术路线

遵循“理论建构—现状调查—问题诊断—对策提出”的技术路线。

第二章 相关概念与理论基础

2.1 核心概念界定

健康乡村：指以保障和促进农村居民身心健康为核心目标，通过优化乡村空间布局、完善公共服务设施、改善人居环境和培育健康生活方式，实现“生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的现代化乡村形态。

农村公共服务设施：本研究所指的农村公共服务设施，重点聚焦教育设施、医疗设施、养老服务设施、文体设施及基础设施五大类。

适老化：指为适应老年人身心特点和生活需求，对居住环境、公共服务设施等进行改造优化，提高老年人生活的安全性、便利性和舒适性。

2.2 相关理论基础

健康地理学为从空间视角研究公共服务设施与居民健康的关系提供了理论基础。公共服务设施区位理论强调设施布局应兼顾效率与公平。健康乡村理论强调乡村健康是涉及环境、经济、社会、文化等多维度的综合性议题。人口老龄化理论为理解农村公共服务设施的适老化需求提供了人口学基础。^{[8][9]}

第三章 罗田县胜利镇公共服务设施现状调查

3.1 研究区域概况

胜利镇位于湖北省黄冈市罗田县东北部，地处大别山南麓，属典型的山区丘陵地带，地势北高南低，最高海拔约 800 米。镇域总面积约 156 平方公里，下辖 23 个行政村和 1 个社区，村庄分布较为分散，自然村之间平均距离约 3-5 公里，部分偏远村庄距离镇中心超过 15 公里。全镇户籍人口约 3.2 万人，常住人口约 1.8 万人，人口外流率超过 40%。



3.1.1 胜利镇入口图（来源：调研拍摄）

从人口结构来看，胜利镇呈现明显的老龄化特征。根据调研数据，全镇 60 岁以上老年人口约 6500 人，占常住人口的比例高达 36.1%，远高于全国农村平均水平（约 23%）。其中，80 岁以上高龄老人约 850 人，失能、半失能老人约 320 人。青壮年劳动力（20-55 岁）约 5200 人，占常住人口的 28.9%，其中多数为季节性返乡务工人员，长期在村劳动力不足 2000 人。学龄儿童（6-15 岁）约 1100 人，占常住人口的 6.1%。常住人口以老年人和儿童为主的“一老一小”结构特征突出，对公共服务设施的需求呈现特殊化、多元化趋势。

经济方面，胜利镇以农业为主导产业，主要种植水稻、茶叶、板栗等，村集体经济收入普遍偏低，2024 年全镇村均集体收入约 12 万元，其中约 60%来自上级转移支付。村民人均可支配收入约 1.2 万元，低于罗田县平均水平（1.5 万元）。薄弱的集体经济和较低的村民收入水平，制约了公共服务设施的自主投入和可持续管护能力。



3.1.2 麻城市果园合作社（来源：调研拍摄）

3.2 教育设施现状

3.2.1 设施布局与规模

胜利镇现有中学 1 所（胜利镇初级中学），中心小学 1 所（胜利镇中心小学），以及 6 个村级小学或教学点（其中 3 个为不完全小学，仅设 1-3 年级）。镇中心学校位于镇政府驻地，服务半径约 5 公里，主要覆盖镇区及周边 5 个行政村。村级教学点分布在松子关村、黄泥畈村、瓦屋基村等偏远村庄，规模普遍偏小：最小的教学点仅有 7 名学生、2 名教师，最大的村小也只有 86 名学生。调研发现，近五年因生源持续流失，已有 4 个教学点被撤并，导致部分村庄学龄儿童上学距离显著增加。



3.2.2 胜利镇中学图（来源：调研拍摄）

3.2.3 硬件设施条件

镇中心学校基础设施相对完善：中学建有教学楼 2 栋（24 间教室）、综合实验楼 1 栋、300 米环形跑道操场 1 个、篮球场 2 个、图书室 1 间（藏书 1.2 万册）。中心小学建有教学

楼 1 栋（18 间教室）、简易操场 1 个（水泥地面篮球场）。两校均配备了多媒体教室和计算机教室，但设备老化问题突出——近 40%的教学电脑无法正常使用。

村级教学点设施普遍简陋：调查的 6 个教学点中，有 4 个校舍为上世纪八九十年代建筑，存在墙体开裂、屋面渗漏等问题；仅 2 个教学点有简易篮球场（均为泥土或水泥地面），无田径跑道和体操器械；实验器材严重匮乏，科学课基本靠教师口头讲授；多媒体教学设备覆盖率不足 20%，且多数为老旧投影仪。体育器材方面，按国家标准小学应配备篮球、足球、排球等球类及跳绳、毽子等，但实际平均每校仅有篮球 5 个、乒乓球拍 3 副，且多数已损坏。



3.2.4 中学教学楼图（来源：调研拍摄）

3.2.5 师资力量

镇中心学校师资相对充足：中学有专任教师 52 人，本科及以上学历占比 78.8%；小学有专任教师 38 人，本科及以上学历占比 65.8%。学科结构基本合理，但体育、音乐、美术等专业教师仍存在缺口（中学缺 2 名体育教师，小学缺 3 名音体美教师）。

村级教学点师资严重短缺：6 个教学点共有教师 21 人，其中 50 岁以上教师 14 人（占 66.7%），具有本科学历的仅 3 人（占 14.3%）。教师身兼多科教学现象普遍，平均每人承担 2.8 门课程教学任务。由于缺乏专业体育教师，体育课多由班主任兼任，教学内容以自由活动为主，难以达到国家课程标准。调研中多位村小教师反映，近十年没有年轻教师主动申请到教学点工作，教师老龄化问题日益严峻。

3.2.6 学生就学困难

问卷调查显示，居住在偏远村庄的学生中，有 62.3%的学生上学单程通勤时间超过 40 分钟，其中 23.5%超过 1 小时。由于缺乏校车服务，多数学生由家长骑行摩托车接送，雨雪天气安全隐患突出。部分家庭经济困难的学生选择在镇区租房陪读，每年增加房租支出约 3000-5000 元，加重了家庭负担。



3.2.7 中学教学楼图（来源：调研拍摄）

3.3 医疗设施现状

3.3.1 设施配置

胜利镇现有镇卫生院 1 所，位于镇中心，建筑面积约 1800 平方米。卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、检验科、放射科等科室，核定床位 40 张，实际开放 32 张。配备有 DR 机、B 超机、心电图机、全自动生化分析仪等设备，但 CT、核磁共振等大型设备缺乏，部分设备（如 B 超机）已使用超过 8 年，性能老化。

村卫生室方面，全镇 23 个行政村均设有卫生室，其中 15 个为标准化卫生室（建筑面积 ≥ 60 平方米，四室分开），8 个为非标准化卫生室（面积不足或功能分区不合理）。村卫生室设备配置普遍简陋：仅有听诊器、血压计、体温计“老三样”的卫生室占 65.2%；配备血糖仪、简易制氧机的占 34.8%；配备心电图机的仅占 13.0%。药品种类方面，村卫生室平均常备药品约 80 种，主要为感冒药、退烧药、消炎药、肠胃药等常见病用药，慢性病用药（如降压药、降糖药）品种不全且时常断供。



3.3.2 中学教学楼图（来源：调研拍摄）

3.3.3 服务能力

镇卫生院能够开展常见病、多发病的诊疗和一级手术（如阑尾切除、疝气修补等），年门诊量约 3.2 万人次，年住院量约 1100 人次。但由于缺乏高端设备和专科人才，对于心脑血管意外、严重创伤等急危重症，仍需转诊至罗田县人民医院（距离约 45 公里，车程约 1 小时）。

村卫生室主要提供常见病初步诊断、小伤处理、疫苗接种、健康档案管理等基础服务。调研访谈发现，村卫生室在慢性病管理方面能力薄弱：虽然承担了高血压、糖尿病患者的定期随访任务，但由于缺乏血糖仪、尿常规检测等设备，随访质量难以保证；在康复护理方面几乎空白，村医普遍不具备专业的康复知识和技能。

3.3.4 人员结构

镇卫生院现有卫生技术人员 58 人，其中执业医师 18 人（含主治医师 6 人），执业助理医师 8 人，注册护士 22 人，其他技术人员 10 人。高级职称仅 3 人（副主任医师），本科学历占比 41.4%，高学历、高职称人才匮乏。

村卫生室共有乡村医生 29 人，其中执业助理医师资格者仅 4 人，其余为乡村医生执业证书。学历结构：中专及以下占 79.3%，大专占 17.2%，本科及以上学历仅 1 人（占 3.4%）。年龄结构：50 岁以上占 55.2%，35 岁以下仅占 6.9%。近十年，仅 2 名医学毕业生到村卫生室工作，且均已离职，后继乏人问题极为严峻。培训方面，村医年均参加县级培训约 2 次，每次 1-3 天，培训内容以传染病防控、基本公卫为主，临床技能和慢性病管理培训不足。

3.3.5 村民就医行为

问卷调查显示，村民患病后首选村卫生室的占 58.6%，首选镇卫生院的占 31.4%，直接去县城医院的占 10.0%。选择去县城医院的主要原因依次为：村卫生室/镇卫生院治不好（67.5%）、设备不行（52.3%）、药不全（41.7%）。村民对村卫生室的满意度评分为 3.2 分（5 分制），主要不满意项为“设备落后”（62.1%）、“药品种类少”（58.6%）、“村医水平有限”（47.8%）。

3.4 养老服务设施现状

3.4.1 设施类型与规模

胜利镇现有公办养老院 1 所（胜利镇福利院），位于镇区边缘，占地约 5 亩，建筑面积 1200 平方米，核定床位 60 张，实际入住老人 48 人。入住率为 80%。此外，全镇有 3 个行政村建有日间照料中心（分别为瓦屋基村、松子关村、黄泥畈村），均为利用闲置村委会或校舍改造而成，每处面积约 80-120 平方米。其他 20 个行政村无任何形式的养老服务设施。



3.4.2 胜利镇政府图（来源：调研拍摄）

3.4.3 设施条件与服务内容

镇福利院居住条件较为基础：房间为 2-3 人间，配有床、衣柜、电视，但缺乏独立卫生间；公共区域设有活动室 1 间（约 40 平方米，配有棋牌桌 2 张）、食堂 1 间。院内缺乏无障碍设施——楼梯无扶手、卫生间无防滑垫和扶手、地面有高差。医疗方面，福利院未设医务室，仅与镇卫生院签订合作协议，卫生院每月派医生巡诊 1 次。护理人员共 6 名，均为本地农村妇女，无专业护理资格证书，主要提供生活照料（打扫卫生、送饭），无法提供康复护理、健康监测等专业服务。

日间照料中心服务内容较为单一：主要为老年人提供棋牌娱乐、茶水供应、临时休息等服务，能够提供午餐的仅 1 处（瓦屋基村），且因经费不足，每周只开放 3 天。所有日间照料中心均未配备康复器材，缺乏专业的服务人员。

3.4.4 适老化改造现状

对全镇公共服务设施的适老化情况进行了专项调查，结果显示：镇卫生院无障碍设施覆盖率约 40%（设有坡道但坡度偏陡，无无障碍卫生间）；村卫生室无障碍设施覆盖率不足 15%；村委会等公共建筑无障碍覆盖率约 25%；村内主要道路无障碍设施（坡道、扶手）覆盖率不足 5%。老年人家庭适老化改造方面，全镇仅 12 户特困老人家庭在民政部门支持下进行了改造（安装卫生间扶手、防滑地砖等），改造覆盖率不足 0.5%。

3.4.5 老年人养老服务需求

问卷调查显示，胜利镇老年人养老服务需求强烈：82.3%的受访老人希望建立或完善村级养老服务中心，提供餐饮、医疗、娱乐服务；67.8%的老人需要定期健康体检和慢性病管理服务；45.6%的独居或高龄老人希望获得助餐、助浴、助洁等上门服务；对于失能、半失能老人家庭，83.3%的家庭反映“一人失能，全家失衡”，照护负担沉重，亟需专业护理支持。

3.5 文体与健身设施现状

3.5.1 文体设施

全镇 23 个行政村中，建有文化广场的村有 18 个（覆盖率 78.3%），其中面积≥500 平方米的仅 5 个。文化广场普遍设施简陋：仅有水泥硬化地面，配有宣传栏 1-2 个，部分配有简易舞台。配有室内文化活动场所（如图书室、活动室）的村仅 7 个（覆盖率 30.4%），且多数面积狭小（<50 平方米），藏书量不足 500 册，开放时间不固定。调查显示，村民每周参与文体活动的时间平均为 1.8 小时，远低于城镇居民（约 5.6 小时）。

3.5.2 健身设施

文化广场配备健身器材的村有 12 个（覆盖率 52.2%），但器材配置存在三大问题：一是种类单一，以漫步机、太极揉推器、腰背按摩器等低端器材为主，缺乏力量训练、有氧训练等多样化器材；二是数量不足，平均每个广场仅配备 6-8 件器材，难以满足多人同时使用；三是适老化设计不足，缺乏适合高龄老人使用的低强度、坐式器材。此外，约 35%的器材因长期使用缺乏维护出现锈蚀、松动甚至损坏，存在安全隐患。健身场地夜间照明设施覆盖率不足 30%，雨雪天气无法使用。

3.5.3 老年人活动场所

针对老年人的专门活动场所严重缺乏。调查发现，老年人日常活动主要聚集于村口大树下（42.3%）、小卖部门口（31.7%）、自家门口（18.6%），仅有 7.4%的老年人会去文化广场。这些自发聚集点普遍缺乏遮阳避雨设施、舒适座椅（带靠背、扶手）和卫生设施，舒适性和安全性均较差。



3.5.4 胜利镇活动场所图（来源：调研拍摄）

3.6 基础设施现状

3.6.1 道路交通

全镇农村公路总里程约 210 公里，其中县道 18 公里，乡道 65 公里，村道 127 公里。道路硬化率：县道和乡道 100%硬化，村道硬化率约 78%，仍有约 28 公里村组道路和入户路为砂石路面或土路，雨天泥泞难行。路面宽度方面，主干道（县道、乡道）宽度 5-7 米，基本满足会车需求；村道宽度普遍 3-4 米，其中宽度不足 3.5 米的危险路段约 35 公里，会车困难，且临崖、急弯路段缺乏防护栏，安全隐患突出。近三年，全镇发生农村道路交通安全事故 11 起，其中 4 起发生在学校周边路段。



3.6.2 道路现状图（来源：调研拍摄）

3.6.3 给排水与环卫

供水方面，全镇已实现集中供水覆盖率约 85%，但部分高山村庄（如松子关村、瓦屋基村）仍依赖山泉水或浅井水，旱季水量不足，雨季水质浑浊。排水方面，镇区建有简易排水沟，但多数村庄采用自然散排，排水系统覆盖率不足 40%。雨季时，15 个行政村存在不同程度的内涝问题，积水深度可达 20-50 厘米。污水处理方面，全镇无集中式污水处理设施，生活污水直排现象普遍，部分沟渠存在黑臭水体。

环卫设施方面，全镇设置垃圾收集点 85 处，配置垃圾桶 340 个，基本实现每 20-30 户 1 个垃圾桶。但垃圾分类尚未推行，垃圾混投现象普遍。垃圾清运采用“村收集、镇转运”模式，但清运频率不足（夏季每周 2-3 次，冬季每周 1-2 次），夏季垃圾堆积发酵产生异味、滋生蚊蝇问题突出。公共厕所方面，全镇仅有 8 座公厕（镇区 4 座，各村共 4 座），数量严重不足，且部分公厕设施损坏、卫生状况差。



3.6.4 电力与通信

电力方面，全镇已实现户户通电，但部分老旧线路存在线径细、绝缘老化等问题，2024 年发生因线路故障导致的停电事件 7 次。通信方面，4G 信号行政村覆盖率达 100%，但自然村覆盖率约 85%，偏远自然村信号弱。宽带光纤通村率约 70%，入户率不足 30%，部分村民上网不便，影响远程医疗、在线教育等服务的推广。

第四章 健康视角下公共服务设施问题分析

4.1 公共服务设施可达性分析

4.1.1 GIS 网络分析结果

本研究运用 ArcGIS 软件，以胜利镇道路网络为基础数据（总里程 210 公里，道路等级分为县道、乡道、村道三级，设定时速分别为 40km/h、25km/h、15km/h），构建了道路网络数据集。以各行政村村委会为起点，分别计算到教育设施（小学、中学）、医疗设施（村卫生室、镇卫生院）的最短路径时间和距离。

教育设施可达性：全镇行政村到最近小学的平均通行时间为 18.5 分钟，其中 12 个村（占 52.2%）在 15 分钟内可达，6 个村（26.1%）在 15-30 分钟，5 个村（21.7%）超过 30 分钟。最远的松子关村到中心小学需 52 分钟。到中学的平均通行时间为 32.6 分钟，15 分钟内可达的仅 3 个村（13.0%），超过 30 分钟的有 14 个村（60.9%）。按照国家《农村普通中小学校建设标准》（建标 109-2008）规定的“小学服务半径不宜大于 2 公里、初中不宜大于 5 公里”，胜利镇小学服务半径达标村比例为 65.2%，初中服务半径达标村比例仅为 30.4%。

医疗设施可达性：到村卫生室的平均通行时间为 9.8 分钟，15 分钟内可达的村有 19 个（82.6%），基本实现“15 分钟就医圈”全覆盖。到镇卫生院的平均通行时间为 28.5 分钟，30 分钟内可达的村有 14 个（60.9%），超过 30 分钟的有 9 个村（39.1%）。值得注意的是，偏远村庄到镇卫生院的实际通行时间受道路条件影响较大，雨雪天气时部分路段无法通行，实际可达性更差。

4.1.2 服务盲区识别

通过缓冲区分析和网络服务区分析，识别出胜利镇公共服务设施的服务盲区。教育服务盲区主要集中在东北部和西南部偏远山区，涉及 5 个行政村约 120 名学龄儿童，这些儿童每天上学单程距离超过 5 公里（小学）或 10 公里（初中）。医疗服务盲区主要集中在海拔较高、道路条件差的 4 个行政村，这些村庄的居民到镇卫生院就医需绕行山路，实际距离超过 15 公里。此外，养老服务设施的服务盲区几乎覆盖全镇——除镇区周边 3 个村外，其余 20 个行政村均无任何养老服务设施覆盖。

4.1.3 地形与道路条件的制约

通过相关性分析发现，村庄海拔高度与到镇卫生院的通行时间呈显著正相关（Pearson 相关系数 $r=0.73$, $p<0.01$ ），海拔每升高 100 米，通行时间平均增加约 8 分钟。道路等级也是重要制约因素——全程为硬化道路的村庄平均通行时间比含砂石路的村庄短 37.2%。这说明山区地形和道路条件是制约设施可达性的关键因素，单纯依靠增加设施数量难以根本解决可达性问题，必须同步改善交通条件。

4.2 设施供给与老龄化需求的错位

4.2.1 医疗服务供需错位

胜利镇 60 岁以上老年人口占比高达 36.1%，老年人慢性病患率约为 78.6%（高血压

51.3%、糖尿病 23.5%、关节炎 32.8%），对慢性病管理、定期体检、康复护理等服务的需求远高于急性病诊疗。然而，现行医疗服务的供给结构与此严重错位：村卫生室的服务内容以常见病、多发病的急性期诊疗为主，慢性病管理仅停留在定期测量血压、血糖（且设备不足），缺乏系统的健康干预和用药指导。问卷调查显示，73.6%的慢性病老人希望获得更专业的慢病管理服务，但仅有 12.4%认为村卫生室能满足需求。

康复护理服务几乎空白。全镇无一家医疗机构设有康复科，村医均不具备专业康复技能。对于脑卒中后遗症、骨折术后等需要康复训练的老人，只能居家自行恢复，效果不佳且存在二次损伤风险。

老年病专科缺失。镇卫生院未设老年病科，老年人多病共存、用药复杂的特点未得到针对性诊疗服务。

4.2.2 养老服务供需错位

胜利镇养老服务的供给与需求存在三个层面的错位：

一是服务模式错位。当前以家庭养老为主（占 98.5%），机构养老为辅（占 1.5%），而社区养老（日间照料、上门服务）几乎空白。但调查显示，72.5%的老年人倾向于“居家养老+社区支持”的模式，即居住在家中，由社区提供餐饮、医疗、照护等上门服务，而非入住养老院。

二是服务内容错位。现有养老服务以生活照料（食宿、卫生）为主，而老年人最急需的是医疗康复（86.2%）、精神慰藉（74.3%）、助餐（68.5%）、助浴（52.1%）等服务，现有设施难以提供。

三是服务对象错位。失能、半失能老人是最需要专业照护的群体，但全镇仅有镇福利院能接收部分失能老人，且护理能力不足；居家失能老人完全依赖家庭成员照护，83.3%的家庭反映照护负担沉重，甚至“一人失能，全家失衡”。

4.2.3 适老化设施普遍缺失

对全镇公共服务设施的适老化专项评估结果显示：无障碍设施总体配置率不足 15%。其中，村卫生室无障碍通道配置率仅 8.7%，无扶手、无防滑地面；镇卫生院虽有坡道但坡度偏陡（约 1:8，标准应为 1:12），轮椅通行困难；村内道路几乎无盲道、无坡道，台阶、高差随处可见。公共活动场所休息座椅配置率不足 30%，且多为无靠背石凳，不适合老年人长时间使用。夜间照明覆盖率不足 40%，老年人夜间出行安全隐患突出。

这种适老化缺失不仅影响老年人的生活质量，还直接威胁其人身安全。据镇卫生院统计，2024 年接诊的老年人意外伤害病例中，跌倒/摔伤占 58.3%，其中约 70%与道路高差、地面湿滑、照明不足等环境因素有关。

4.3 设施服务质量与管护困境

4.3.1 服务质量参差不齐

教育方面，镇中心学校教学质量在全县乡镇学校中排名中等偏上（第 8/23），但村小及教学点学生成绩普遍低于镇中心学校，2024 年期末统测中，村小学生平均分比镇中心小

学低 18.6 分。医疗方面，镇卫生院诊疗水平有限，2024 年转诊率为 12.5%，高于县级医院平均水平（约 8%）；村卫生室诊疗量呈下降趋势，2024 年较 2020 年下降了 23.6%，反映出村民对村级医疗服务的不信任。文体设施因缺乏专人管理和活动组织，文化广场使用率不足 30%，健身器材闲置率高。^[10]

4.3.2 管护责任不清

调查发现，公共服务设施的管护存在“多头管理、无人负责”的困境。以村卫生室为例：建设由县卫健局负责，设备由镇卫生院调配，房屋由村委会提供，日常管护责任却无明确规定。设施损坏后，村医不知该向谁报告，往往拖延数月甚至一年才能修复。道路管护同样存在问题：村道建设由县交通局负责，建成后移交村委会管护，但村委会无专项资金和专业人员，导致路面破损后长期得不到修复。^[11]

调研中，71.4%的村干部反映“设施管护是当前最大的难题”，主要困难依次为：缺乏资金（85.7%）、责任不清（64.3%）、缺乏专业技术人员（57.1%）。这种“重建设、轻管理”的现象并非胜利镇独有，而是农村公共基础设施领域的普遍问题。正如已有研究所指出的，自上而下的输入性供给模式缺乏激励机制，造成很多设施建成后未能得到妥善管护。

4.3.3 资金与人才双重短缺

资金方面，胜利镇公共服务设施管护资金来源单一，主要依赖上级财政转移支付。2024 年，全镇用于设施管护的财政资金约 45 万元，但据测算实际需求约 120 万元，缺口达 62.5%。村级层面，集体经济收入有限，无力承担设施管护费用。以道路维护为例，每公里村道年维护成本约 2000 元，全镇 127 公里村道需 25.4 万元，但实际投入不足 8 万元，导致“修路容易养路难”。

人才方面，专业人才短缺是制约服务质量提升的根本性障碍。乡村医生学历低、年龄大、知识老化，且近十年无新人补充；村小教师老龄化严重，音体美专业教师为零；养老服务领域更是无一名持证护理人员。由于工作环境差、待遇低、职业发展空间有限，年轻人才“下不去、留不住”的问题短期内难以破解。

第五章 规划优化建议

5.1 构建“健康乡村”公共服务设施评价体系

在 AHP 评价模型基础上，构建包含可达性、服务质量、适老化水平、管护效能四个维度共 13 项指标的评价体系。参照国家相关标准（如《村卫生室服务能力标准》《农村普通中小学校建设标准》等）确定评分标准。建议将评价纳入乡村振兴考核体系，定期开展评价排名，评价结果作为设施建设投入和管护资金分配的重要依据。

5.2 优化公共服务设施空间布局

教育设施：整合教育资源，撤并规模过小的教学点，集中力量办好中心学校；优化校车服务；将闲置校舍改造为老年学校或社区教育中心。

医疗设施：构建“镇卫生院+中心村卫生室+普通村卫生室”三级网络，推进远程医疗向乡村覆盖，建立镇村医疗服务联动机制。

养老服务设施：构建多层次养老服务体系，推动医养结合，探索“中心带点”模式，确保养老服务覆盖无死角。

5.3 提升设施适老化水平

全面推进无障碍环境建设，对公共建筑和主要道路进行适老化改造。在服务内容上，医疗卫生设施增设老年病专科、康复理疗室，发展上门服务模式。文体设施增设适合高龄老人的低强度健身设施。积极探索智慧养老技术应用，为高龄独居、失能老人配备紧急呼叫器，建立应急响应机制。

5.4 完善设施管护长效机制

建立“政府主导、部门协同、村级落实、村民参与”的管护责任体系。整合各类涉农资金，探索“政府补一点、集体出一点、个人拿一点”的多元筹资模式。多措并举加强专业人才培养，落实大学生乡村医生专项计划，建立人才“下沉”与“流动”机制。推行市场化管护和智慧化管理，建立设施管护评价考核机制。

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

通过本项目的调研与分析，罗田县胜利镇公共服务设施主要面临三大核心困境：一是缺乏科学的评价指标体系，设施规划缺少健康视角的引导；二是设施供给与老龄化需求严重错位，全镇 60 岁以上老年人占比达 36.1%，但适老化设施配置率不足 15%，慢性病管理、康复护理等服务基本空白；三是管护机制不完善，“重建设、轻管理”现象突出，资金和人才双重短缺。运用 AHP 评价模型对胜利镇公共服务设施进行定量评价，综合得分为 65.7 分，其中服务质量和适老化水平是主要短板。针对上述问题，本项目构建了“健康乡村”视角下的公共服务设施评价体系（包含可达性、服务质量、适老化水平三个维度），并提出了优化空间布局、提升适老化水平、完善管护机制等对策建议。

6.2 研究创新与不足

本研究的创新之处在于将健康乡村理念从医疗卫生领域延伸至教育、养老等领域，融合了 GIS 空间分析、层次分析法和实地调查等多种方法，并以真实案例为基础提出了可操作的规划建议。不足之处在于：调研样本仅覆盖一个乡镇，结论的普适性有限；缺乏对设施改善效果的长期追踪评估；未进行跨区域比较研究。

6.3 未来展望

如果条件允许，后续研究可以开展跨区域比较，对不同类型乡镇的公共服务设施进行对比分析；对已提出的建议实施效果进行追踪评估；将研究范围拓展至文化服务、应急服务等领域；以及加强微观层面的居民行为研究，更精准地把握农村居民的实际需求。

参考文献

- [1] 吴建军, 孔云峰, 李斌. 基于 GIS 的农村医疗设施空间可达性分析——以河南省兰考县为例[J]. 人文地理, 2008, 23(5): 37-42.
- [2] 杨俊, 张宇, 李静. 基于 GIS 分析的黔西市公共服务设施空间布局研究[J]. 重庆建筑, 2024, 23(8): 45-49.
- [3] 刘小英, 王芳, 陈晨. 乡村公共服务设施适老化布局评估及优化策略——以铅山县为例[J]. 中外建筑, 2024, 36(9): 82-87.
- [4] 蔡云楠, 王盛喆, 张鹏. 乡村社区“柔性生活圈”构建与配置策略: 以广东省云浮市碧塘村为例[J]. 规划师, 2025, 41(5): 138-144.
- [5] 杨慧. 脱贫地区乡村公共服务设施精准规划研究——以云南省彝良县为例[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2023.
- [6] 国家卫生健康委, 全国爱卫办, 国家发展改革委, 等. 关于推进健康乡村建设的指导意见(国卫财务发〔2024〕28号)[EB/OL]. (2024-09-04).
- [7] 季顺伟, 蒋海兵, 任丽燕, 等. 江苏农村公共服务的可达性与居民满意度空间分异[J]. 上海国土资源, 2021, 42(2): 56-62.
- [8] 陈枫. 基于 GIS 网络分析法的农村文化设施可达性分析及布局优化[D]. 西安: 长安大学, 2019.
- [9] 谭敏, 高莉. 城乡融合视角下的乡村公共服务设施建设与管理策略研究[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2025, 15(14): 112-115.
- [10] 李元芳, 乔伟峰, 杨春花, 等. 基于公共服务设施可达性的村镇建设格局评价及优化策略研究——以常州市金坛区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2024, 40(1): 106-113.
- [11] 我国乡村公共基础设施建设管护机制的政策演变及优化[J]. 乡村论丛, 2024, 3(3): 23-30.